Liga Acadêmica Cognitivo-Comportamental (LACC)

ABA e TEA

da análise funcional à decisão clínica

Betina Binatti

24 de outubro de 2026, PUCRS

Quem conduz o workshop

Betina Binatti

- Psicóloga formada pela PUCRS
- Pós-graduada em ABA e Estratégias Naturalistas (Instituto Singular)
- Pós-graduanda em Neuropsicologia (Comportamente)
- 7 anos de experiência em neurodivergência
- 2 anos e 6 meses como coordenadora de caso e supervisora clínica

Ao final, vocês vão conseguir

1. Explicar por que o TEA é heterogêneo
2. **Diferenciar topografia e função**
3. **Identificar antecedentes, consequências e contexto**
4. **Justificar por que avaliar vem antes de intervir**
5. Reconhecer estratégias baseadas em evidências e ligá-las à função
6. Analisar uma vinheta e justificar decisões
7. Reconhecer limites de atuação e a importância da supervisão

Este workshop não forma aplicadores

O que é

Uma introdução ao raciocínio analítico-comportamental aplicado ao TEA.

O que não é

Um curso de formação em ABA. Ele não habilita ninguém a avaliar ou intervir sem formação e supervisão.

Combinados

- Perguntas são bem-vindas a qualquer momento
- Todos os casos são fictícios
- Não vamos discutir casos reais
- Vamos usar “pessoa autista”, respeitando preferências individuais

Uma criança grita e se joga no chão quando a atividade muda.

Por quê?

Exemplo fictício

O diagnóstico de TEA se apoia em dois domínios

Comunicação e interação social

Diferenças persistentes, em vários contextos.

Padrões restritos e repetitivos

De comportamento, interesses ou atividades, incluindo respostas sensoriais.

Os sinais aparecem no início do desenvolvimento e têm impacto significativo no funcionamento.

American Psychiatric Association (2022), DSM-5-TR

Especificadores e níveis de gravidade

Especificadores: com ou sem deficiência intelectual, com ou sem comprometimento de linguagem, condições associadas.

Nível	Necessidade de apoio
1	Exige apoio
2	Exige apoio substancial
3	Exige apoio muito substancial

Os níveis são definidos para cada domínio e descrevem necessidade de apoio, não “grau de autismo”.

O diagnóstico não define o plano

Duas pessoas autistas podem ser muito diferentes em linguagem, capacidade intelectual, necessidade de apoio, condições coocorrentes, interesses e contexto familiar.

O plano nasce da avaliação da pessoa, não do rótulo.

Lord et al. (2020); Lord et al. (2022)

Prevalência depende de onde e como se mede

≈ 1%

Estimativa global (mediana de 100 por 10.000 em estudos de vários países)

1 em 31

Crianças de 8 anos em 16 regiões dos EUA, em 2022

Parte da variação reflete práticas de identificação e acesso a avaliação.

Zeidan et al. (2022); Shaw et al. (2025)

Neurodiversidade: diferença não é algo a “curar”

- O autismo como parte da variação humana
- Reconhecer dificuldades e respeitar a identidade não são opostos
- A linguagem importa: “pessoa autista”, “interesses focados”

Kapp et al. (2013); Bottema-Beutel et al. (2021)

Se o objetivo não é “tirar o autismo”, o que justifica uma intervenção?

Respostas: o que justifica intervir

Ganho para a pessoa	Exemplo
Comunicação	Ter formas eficazes de pedir, recusar e se expressar
Aprendizagem e participação	Na escola, em casa e na comunidade
Autonomia	Fazer mais por si, com menos ajuda
Segurança	Quando o comportamento machuca a pessoa ou outras pessoas
Qualidade de vida	Bem-estar, interesses e relações

Características autistas inofensivas não são alvo por si só.

Objetivos definidos com a família e, sempre que possível, com a própria pessoa.

ABA é uma ciência aplicada, não um pacote de técnicas

Sete dimensões definem a Análise do Comportamento Aplicada:

- Aplicada
- Comportamental
- Analítica
- Tecnológica
- Conceitualmente sistemática
- Efetiva
- Generalidade

Baer, Wolf & Risley (1968)

Topografia descreve. Função explica.

Topografia

A forma do comportamento: o que se vê e se ouve.

Função

A relação com as consequências que mantêm o comportamento.

A mesma forma pode ter funções diferentes, e formas diferentes podem ter a mesma função.

Exemplo fictício: bater na mesa pode produzir atenção para uma criança e a retirada da tarefa para outra.

Cooper, Heron & Heward (2020); Iwata et al. (1982/1994)

O comportamento acontece entre um antes e um depois

A. Antecedente

O que acontece imediatamente antes

B. Comportamento

O que a pessoa faz, descrito de forma observável

C. Consequência

O que acontece imediatamente depois

Exemplo fictício: a terapeuta guarda o tablet (A), a criança grita e joga o copo no chão (B), o tablet é devolvido (C).

Cooper, Heron & Heward (2020)

O contexto muda o valor das consequências

Variáveis contextuais

Sono, dor, fome, rotina, ambiente sensorial.

Operação motivadora

Altera por um tempo o valor de uma consequência e a frequência dos comportamentos ligados a ela.

Exemplo fictício: depois de uma noite mal dormida, uma tarefa difícil fica mais aversiva, e escapar dela passa a “valer mais”.

Laraway et al. (2003)

Reforçamento se define pelo efeito, não pela intenção

Reforçamento é quando a consequência aumenta a chance de o comportamento voltar a acontecer.

Positivo

Algo é acrescentado. Ex.: a criança recebe atenção.

Negativo

Algo é retirado ou adiado. Ex.: a tarefa sai.

“Negativo” não é punição.

Quatro hipóteses funcionais frequentes

1. Acesso a atenção
2. Acesso a itens ou atividades
3. Fuga ou esquiva de demandas ou estímulos
4. Reforçamento automático: o próprio comportamento produz a consequência

São hipóteses a testar, não rótulos. Podem ser múltiplas ou combinadas.

Iwata et al. (1982/1994); Hanley, Iwata & McCord (2003); Hanley et al. (2014)

Mini-exercício em duplas (5 min)

Nas três situações a seguir, o comportamento é o mesmo: **a criança joga os materiais no chão e chora.**

1. O que acontece logo depois?
2. Que hipótese funcional isso sugere?
3. O que vocês precisariam observar mais?

Desafio: pensem em uma estratégia que ajudaria em uma situação e pioraria outra. Por quê?

Três situações

1. A terapeuta se levanta para atender a mãe na porta. A criança joga os materiais e chora. A terapeuta volta, senta ao lado e conversa até ela se acalmar.
2. A terapeuta apresenta uma folha de escrita. A criança joga os materiais e chora. A terapeuta guarda a folha: “fazemos depois”.
3. A terapeuta guarda o tablet. A criança joga os materiais e chora. Minutos depois, ela devolve o tablet “só mais um pouquinho”.

Exemplo fictício

Mesma topografia, três hipóteses

Situação	O que acontece depois	Hipótese
1	A atenção volta	**Acesso a atenção**
2	A tarefa sai	**Fuga da demanda**
3	O tablet volta	**Acesso a item**

Um episódio não basta: hipóteses se sustentam em **padrões que se repetem**.

Hanley (2012)

Respostas do desafio: a mesma estratégia, efeitos opostos

Estratégia	Onde pode ajudar	Onde pode piorar
Dar um tempo fora da atividade, **sem atenção**	Situação 1: o comportamento deixa de produzir atenção	Situação 2: a criança escapa da tarefa, que era o que mantinha o comportamento
Devolver o tablet “para acalmar”	Na hora, o choro para	Situação 3: o comportamento fica mais forte nas próximas vezes

Por isso, avaliar a função vem antes de escolher a estratégia.

Cada resposta do início era uma hipótese funcional diferente.

Avaliar vem antes de intervir.

Só a avaliação permite escolher entre elas.

ABA e TCC compartilham compromissos empíricos

- Avaliação de resultados com dados
- Alvos definidos de forma operacional
- Formulação individualizada do caso
- Procedimentos baseados em princípios de aprendizagem, como reforçamento, exposição, modelação e treino de habilidades

Aproximação não é equivalência.

ABA e TCC partem de pressupostos diferentes

	ABA	TCC (modelo de Beck)
Base	Behaviorismo radical	Modelo cognitivo
Pensamentos e sentimentos	Comportamentos a explicar	Mediadores e alvo central
Análise	Relação comportamento–ambiente	Situação, pensamento, emoção e comportamento
Formulação	Análise funcional	Conceituação cognitiva

Skinner (1953); Beck (2021)

No TEA, cada abordagem tem evidências em áreas diferentes

Práticas de base comportamental

Têm critério de evidência: FCT, intervenções antecedentes, reforçamento diferencial, intervenção naturalística, entre outras.

TCC adaptada para autismo

Tem evidência de ensaio clínico para ansiedade em crianças autistas de 7 a 13 anos.

Hume et al. (2021); Wood et al. (2020)

Uma adolescente autista, com boa linguagem, evita trabalhos em grupo e diz ter medo de “falar algo errado”.

O que um analista do comportamento perguntaria primeiro? E um terapeuta cognitivo-comportamental?

Exemplo fictício

Respostas: o que cada abordagem perguntaria primeiro

Análise do comportamento

Em que situações ela evita o grupo? O que acontece logo depois? O que mantém esse comportamento?

TCC

Que pensamentos e crenças ela tem sobre falar em grupo (“vou falar algo errado”)? Como eles influenciam a ansiedade e a esquiva?

As duas leituras ajudam a entender o caso, mas não são equivalentes.

Voltamos às 10h45.

Intervalo

Ao voltar, formem grupos de 4 a 6 pessoas.

Três formas de avaliar a função, com limites diferentes

Avaliação	Como	Limite
Indireta	Entrevistas, escalas	Depende do relato de outras pessoas
Descritiva	Observação direta A–B–C	Mostra associação, não causa
Análise funcional	Teste sistemático de condições	Exige profissional qualificado, supervisão e segurança

Hanley, Iwata & McCord (2003); Hanley (2012); BACB (2020)

Prevenir é mudar o contexto, não só reagir

Estratégias antecedentes, escolhidas a partir da hipótese:

- **Previsibilidade:** aviso de transição, apoio visual
- **Ajuste da demanda:** duração, dificuldade, interesse
- **Escolhas** reais
- **Acesso planejado** a pausas e itens preferidos

Cooper, Heron & Heward (2020); Laraway et al. (2003); Hume et al. (2021)

FCT: ensinar a pedir o que o comportamento conseguia

1. Identificar a função
2. Ensinar uma forma de comunicação que produza a mesma consequência (“pausa”, “ajuda”, “mais”)
3. Responder a essa comunicação de forma consistente
4. Ensinar, aos poucos, a esperar e a tolerar um “agora não”

Exemplo fictício: se a hipótese é fuga da tarefa, ensinar a pedir “pausa”, por palavra, gesto, figura ou outro sistema de comunicação.

Carr & Durand (1985); Tiger, Hanley & Bruzek (2008); Hanley et al. (2014)

Ensinar no contexto natural, a partir do interesse da criança

Intervenções Naturalísticas Desenvolvimentais Comportamentais (NDBI):

- Contextos naturais, como o brincar e as rotinas
- Controle compartilhado entre criança e adulto
- Consequências naturais
- Integração entre ciência comportamental e ciência do desenvolvimento

Schreibman et al. (2015); Sandbank et al. (2020)

Generalização precisa ser planejada

Aprender na clínica não garante usar em casa, na escola ou com outras pessoas.

Planejar desde o início: várias pessoas, lugares e materiais, com a família envolvida.

Exemplo fictício: a criança aprende a pedir “pausa” com a terapeuta, e o plano inclui ensinar a família a responder ao mesmo pedido em casa.

Stokes & Baer (1977)

Decidir bem é decidir com ética

- Objetivos com sentido para a vida da pessoa, definidos com a família e com a pessoa
- **Assentimento:** observar sinais de concordância e de recusa
- Não ter como alvo características autistas inofensivas
- Revisar por dados, incluindo possíveis efeitos adversos
- Supervisão e limites de atuação

Breaux & Smith (2023); Sandbank et al. (2023); CFP (2005); BACB (2020)

Atividade em grupos (10 min)

Todos os grupos

Perguntas 1 a 4

Cada grupo, mais uma

Grupos 1, 3, 5…: pergunta 5. Grupos 2, 4, 6…: pergunta 6.

Escolham quem anota e quem apresenta.

A história permite levantar hipóteses, não concluir a função.

Vídeo: Theo, uma sessão

Enquanto assistem, observem:

1. O que acontece imediatamente antes?
2. O que exatamente ele faz?
3. O que acontece imediatamente depois?



Animação, exemplo fictício. Não representa uma criança real. O vídeo mostra um episódio; o padrão está na vinheta a seguir.

Respostas do vídeo

Antes	O que ele faz	Depois
A terapeuta guarda os trilhos e aponta a mesa: “Agora acabou. Vamos para a mesa.”	Grita, se joga no chão e chuta o ar.	A terapeuta não sabe o que fazer e devolve os trilhos. Ele volta a brincar.

E a terapeuta? Devolver os trilhos faz o grito parar e alivia quem está com ele. Esse alívio também pode reforçar o comportamento do adulto, e o ciclo continua.

Vocês viram um episódio. Os registros de quatro semanas, na vinheta, mudam essa leitura.

Vinheta: Theo

Theo tem 6 anos e é autista. Comunica-se principalmente por palavras isoladas e por gestos (puxa o adulto pela mão, aponta). Gosta muito de montar trilhos de trem. Frequenta atendimento clínico três vezes por semana. Nas últimas quatro semanas, a equipe registrou:

- Quando a terapeuta diz “agora acabou, vamos para a mesa”, Theo **grita, se joga no chão e chuta o ar**, por cerca de 3 a 8 minutos. Isso aconteceu em **11 de 12 sessões**, quase sempre na passagem dos trilhos para a atividade de mesa (traçar letras e encaixes).
- Em **duas sessões** em que a terapeuta também guardou os trilhos, mas a atividade seguinte foi o **lanche**, Theo **não** apresentou o comportamento.

Exemplo fictício, parte 1 de 2

Vinheta: Theo (continuação)

- As reações dos adultos variaram: em algumas sessões, a terapeuta esperou e depois **devolveu os trilhos “por mais cinco minutos”**; em outras, **adiou a atividade de mesa** para o fim da sessão; em outras, **manteve a atividade** e conduziu Theo até a mesa.
- A mãe relata que, em casa, Theo reage de forma parecida quando precisa **desligar a televisão para tomar banho**.
- A mãe também conta que, nas semanas em que os episódios foram **mais longos**, Theo **dormiu mal** e houve **troca da terapeuta** que o atendia.
- Nas sessões em que a terapeuta **mostrou um cartão “primeiro trilhos, depois mesa” e avisou dois minutos antes**, os episódios foram **mais curtos** (registro em 3 sessões).

Exemplo fictício, parte 2 de 2

Perguntas para o grupo

Todos os grupos (cerca de 6 min)

1. O que o Theo faz? Descrevam só o que dá para ver e ouvir, sem palavras como “birra” ou “crise”.
2. O que acontece logo antes?
3. O que acontece logo depois?
4. Por que isso pode estar acontecendo? Deem duas explicações possíveis e, para cada uma, um dado da história que ajuda e um que atrapalha.

Cada grupo, mais uma (cerca de 4 min)

5. Escolham uma das explicações. O que vocês fariam para ajudar o Theo? E se essa explicação estiver errada, o que pode dar errado?

6. A mãe pergunta: “Não é melhor tirar os trilhos de vez?”. O que vocês responderiam?

Respostas 1 a 3: o que aconteceu

1. O que ele faz

Grita, se joga no chão e chuta o ar, por 3 a 8 minutos, em 11 de 12 sessões. Sem “birra” ou “crise”: são interpretações.

2. Antes

“Agora acabou, vamos para a mesa”; trilhos guardados; atividade de mesa. Contexto: sono ruim, troca de terapeuta.

3. Depois

Às vezes os trilhos voltam, às vezes a mesa é adiada, às vezes a mesa é mantida.

Sono e troca de terapeuta são contexto, não função.

Respostas 4: explicações possíveis

Explicação	Dado que ajuda	Dado que atrapalha
Quer os trilhos	Acontece quando os trilhos são guardados; às vezes eles voltam; em casa, ao desligar a TV	No lanche os trilhos também foram guardados, e não houve episódio
Foge da mesa	Não acontece quando o próximo é o lanche; às vezes a mesa é adiada	Em casa, o antecedente é o banho
As duas juntas	Os dois antecedentes acontecem ao mesmo tempo	Precisa de avaliação
Quer atenção	Possível atenção durante o episódio	Nenhum dado mostra isso

O lanche é a pista: enfraquece “quer os trilhos” e fortalece “foge da mesa” (ou as duas juntas).

Respostas 5: o que fazer, e se a explicação estiver errada?

Se a explicação for…, podemos…	Se a explicação estiver errada…
Quer os trilhos: “primeiro mesa, depois trem”; ensinar a pedir “mais trem” e a esperar	Se na verdade ele foge da mesa: pouco efeito, a mesa continua difícil
Foge da mesa: tarefa mais curta, com tema de trens; ensinar a pedir “pausa”	Se na verdade ele quer os trilhos: o comportamento na hora de guardar continua
Adiar a mesa quando ele grita, “para acalmar”	**Piora:** ele aprende que gritar funciona

Errar a explicação pode ensinar o contrário do que queremos.

Respostas 6: tirar os trilhos de vez?

- **O interesse não é o problema:** o problema é a transição e o que o comportamento consegue
- **Tirar não ensina nada novo:** Theo continuaria sem saber pedir “mais” ou “pausa”
- **Pode não resolver:** se a função for fugir da mesa, o comportamento continua
- **Os trens podem ser recurso:** tarefas com tema de trem, trilhos combinados para depois

Acolher a família e decidir junto, com plano para casa e supervisão.

Plenária: do comportamento à decisão

Comportamento → Antes e depois → Explicações possíveis → O que fazer → Cuidados éticos

Uma história **não permite concluir a função**. Ela permite levantar hipóteses que precisam de avaliação.

Cinco mensagens para levar

1. TEA é heterogêneo: **o diagnóstico não define o plano**
2. **Topografia descreve; função explica**
3. **Avaliar vem antes de intervir**
4. Bons objetivos ampliam comunicação, participação, autonomia e qualidade de vida
5. Raciocínio clínico exige **evidência, individualização, ética e supervisão**

Perguntas?

Para aprofundar

Leitura	Tema
Baer, Wolf & Risley (1968)	O que define a ABA
Hanley (2012)	Avaliação funcional na prática
Tiger, Hanley & Bruzek (2008)	Treino de Comunicação Funcional
Schreibman et al. (2015)	Intervenções naturalísticas (NDBI)
Sandbank et al. (2020)	Qualidade da evidência em intervenção precoce
Breaux & Smith (2023)	Assentimento

Referências completas nos slides finais

Betina Binatti

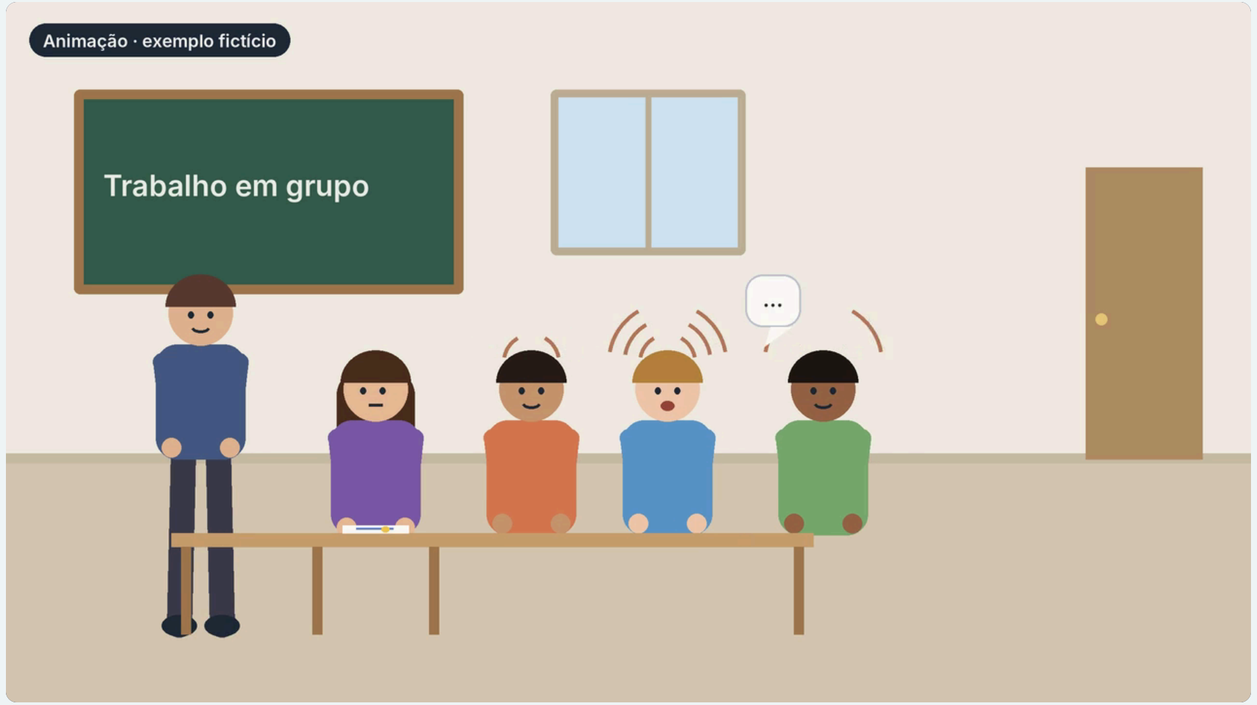
Obrigada!

Workshop ABA e TEA, LACC, PUCRS, 24 de outubro de 2026

Vídeo: Lara, uma aula

Enquanto assistem, observem:

1. O que acontece logo antes?
2. O que a Lara faz?
3. O que acontece logo depois?



Animação, exemplo fictício. Não representa uma pessoa real. O vídeo mostra um episódio; o padrão está na história a seguir.

Reserva: a história da Lara

Lara tem 14 anos, é autista e fala com fluência. Gosta de desenho e de astronomia. Nos últimos dois meses, quando a professora propõe **trabalho em grupo** numa sala barulhenta, Lara **coloca o capuz, abaixa a cabeça e, às vezes, sai da sala sem avisar**. Quando sai, é levada à coordenação e passa o resto da aula na biblioteca. Nas atividades individuais, participa e tira boas notas. Ela disse à psicóloga da escola: “o barulho é demais” e “sempre falo alguma coisa errada nos grupos”.

1. O que a Lara faz? Descrevam só o que dá para ver e ouvir.
2. O que acontece logo antes? E logo depois?
3. Por que isso pode estar acontecendo? Deem duas explicações possíveis.
4. A escola quer que a Lara faça todos os trabalhos sozinha, na biblioteca. Isso ajuda ou atrapalha? O que vocês proporiam no lugar?

Exemplo fictício

Respostas: a história da Lara

Pergunta	Resposta
1. O que ela faz	Coloca o capuz, abaixa a cabeça e sai da sala sem avisar
2. Antes e depois	Antes: trabalho em grupo numa sala barulhenta. Depois: sai do grupo e vai para a biblioteca
3. Explicações possíveis	Fugir do barulho; fugir da conversa em grupo (medo de errar); as duas juntas. Ir para a biblioteca pode reforçar a saída
4. Sempre sozinha na biblioteca?	Alivia agora, mas pode reforçar a fuga e tirar chances de participar. Só serve como algo temporário, combinado com ela
5. O que propor no lugar	Lugar mais silencioso ou protetor de ouvido (se ela quiser), grupo menor, um papel definido no grupo e um jeito combinado de pedir pausa

O capuz, em si, não é problema a eliminar. Decidir junto com a Lara.

Reserva: um dado novo sobre Theo

Na semana seguinte, em 4 sessões, a terapeuta apresentou a atividade de mesa **sem guardar os trilhos** (eles ficaram ao lado, e Theo poderia voltar a eles ao terminar). Em **3 dessas sessões**, Theo não gritou nem se jogou no chão.

Com esse dado, qual explicação fica mais forte? Já dá para ter certeza?

Exemplo fictício

Respostas: o dado novo

O que muda

Fica mais forte a explicação “quer os trilhos” (ou as duas juntas): sem guardar os trilhos, quase não houve episódio. “Foge da mesa” fica mais fraca.

O que não muda

Ainda não dá para ter certeza: são só 4 sessões, sem controle de sono, terapeuta ou tipo de tarefa.

É mais uma pista. O próximo passo é uma avaliação organizada, com supervisão.

Referências: TEA e neurodiversidade

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing.

Bottema-Beutel, K., Kapp, S. K., Lester, J. N., Sasson, N. J., & Hand, B. N. (2021). Avoiding ableist language: Suggestions for autism researchers. *Autism in Adulthood, 3*(1), 18–29. https://doi.org/10.1089/aut.2020.0014

Kapp, S. K., Gillespie-Lynch, K., Sherman, L. E., & Hutman, T. (2013). Deficit, difference, or both? Autism and neurodiversity. *Developmental Psychology, 49*(1), 59–71. https://doi.org/10.1037/a0028353

Lord, C., Brugha, T. S., Charman, T., et al. (2020). Autism spectrum disorder. *Nature Reviews Disease Primers, 6*, 5. https://doi.org/10.1038/s41572-019-0138-4

Lord, C., Charman, T., Havdahl, A., et al. (2022). The Lancet Commission on the future of care and clinical research in autism. *The Lancet, 399*(10321), 271–334. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01541-5

Shaw, K. A., Williams, S., Patrick, M. E., et al. (2025). Prevalence and early identification of autism spectrum disorder among children aged 4 and 8 years — ADDM Network, 16 sites, United States, 2022. *MMWR Surveillance Summaries, 74*(SS-2), 1–22. https://doi.org/10.15585/mmwr.ss7402a1

Zeidan, J., Fombonne, E., Scorah, J., et al. (2022). Global prevalence of autism: A systematic review update. *Autism Research, 15*(5), 778–790. https://doi.org/10.1002/aur.2696

Referências: ABA e análise funcional

Baer, D. M., Wolf, M. M., & Risley, T. R. (1968). Some current dimensions of applied behavior analysis. *Journal of Applied Behavior Analysis, 1*(1), 91–97. https://doi.org/10.1901/jaba.1968.1-91

Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2020). *Applied behavior analysis* (3rd ed.). Pearson.

Hanley, G. P. (2012). Functional assessment of problem behavior: Dispelling myths, overcoming implementation obstacles, and developing new lore. *Behavior Analysis in Practice, 5*(1), 54–72. https://doi.org/10.1007/BF03391818

Hanley, G. P., Iwata, B. A., & McCord, B. E. (2003). Functional analysis of problem behavior: A review. *Journal of Applied Behavior Analysis, 36*(2), 147–185. https://doi.org/10.1901/jaba.2003.36-147

Hanley, G. P., Jin, C. S., Vanselow, N. R., & Hanratty, L. A. (2014). Producing meaningful improvements in problem behavior of children with autism via synthesized analyses and treatments. *Journal of Applied Behavior Analysis, 47*(1), 16–36. https://doi.org/10.1002/jaba.106

Iwata, B. A., Dorsey, M. F., Slifer, K. J., Bauman, K. E., & Richman, G. S. (1994). Toward a functional analysis of self-injury. *Journal of Applied Behavior Analysis, 27*(2), 197–209. https://doi.org/10.1901/jaba.1994.27-197 (Original publicado em 1982)

Laraway, S., Snycerski, S., Michael, J., & Poling, A. (2003). Motivating operations and terms to describe them: Some further refinements. *Journal of Applied Behavior Analysis, 36*(3), 407–414. https://doi.org/10.1901/jaba.2003.36-407

Referências: ABA, TCC e intervenção

Beck, J. S. (2021). *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond* (3rd ed.). Guilford Press.

Carr, E. G., & Durand, V. M. (1985). Reducing behavior problems through functional communication training. *Journal of Applied Behavior Analysis, 18*(2), 111–126. https://doi.org/10.1901/jaba.1985.18-111

Hayes, S. C., & Hofmann, S. G. (2017). The third wave of cognitive behavioral therapy and the rise of process-based care. *World Psychiatry, 16*(3), 245–246. https://doi.org/10.1002/wps.20442

Hume, K., Steinbrenner, J. R., Odom, S. L., et al. (2021). Evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism: Third generation review. *Journal of Autism and Developmental Disorders, 51*(11), 4013–4032. https://doi.org/10.1007/s10803-020-04844-2

Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. Macmillan.

Tiger, J. H., Hanley, G. P., & Bruzek, J. (2008). Functional communication training: A review and practical guide. *Behavior Analysis in Practice, 1*(1), 16–23. https://doi.org/10.1007/BF03391716

Wood, J. J., Kendall, P. C., Wood, K. S., et al. (2020). Cognitive behavioral treatments for anxiety in children with autism spectrum disorder: A randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry, 77*(5), 474–483. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.4160

Referências: estratégias naturalistas e evidência

Sandbank, M., Bottema-Beutel, K., Crowley, S., et al. (2020). Project AIM: Autism intervention meta-analysis for studies of young children. *Psychological Bulletin, 146*(1), 1–29. https://doi.org/10.1037/bul0000215

Sandbank, M., Bottema-Beutel, K., Crowley LaPoint, S., et al. (2023). Autism intervention meta-analysis of early childhood studies (Project AIM): Updated systematic review and secondary analysis. *BMJ, 383*, e076733. https://doi.org/10.1136/bmj-2023-076733

Schreibman, L., Dawson, G., Stahmer, A. C., et al. (2015). Naturalistic developmental behavioral interventions: Empirically validated treatments for autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders, 45*(8), 2411–2428. https://doi.org/10.1007/s10803-015-2407-8

Stokes, T. F., & Baer, D. M. (1977). An implicit technology of generalization. *Journal of Applied Behavior Analysis, 10*(2), 349–367. https://doi.org/10.1901/jaba.1977.10-349

Referências: ética e assentimento

Behavior Analyst Certification Board. (2020). *Ethics code for behavior analysts*. https://bacb.com/wp-content/ethics-code-for-behavior-analysts/

Breaux, C. A., & Smith, K. (2023). Assent in applied behaviour analysis and positive behaviour support: Ethical considerations and practical recommendations. *International Journal of Developmental Disabilities, 69*(1), 111–121. https://doi.org/10.1080/20473869.2022.2144969

Conselho Federal de Psicologia. (2005). *Código de ética profissional do psicólogo* (Resolução CFP nº 010/2005).

Leaf, J. B., Cihon, J. H., Leaf, R., et al. (2022). Concerns about ABA-based intervention: An evaluation and recommendations. *Journal of Autism and Developmental Disorders, 52*(6), 2838–2853. https://doi.org/10.1007/s10803-021-05137-y

Newcomb, E. T., & Wine, B. (2023). A brief response to assent in applied behaviour analysis and positive behaviour support: Ethical considerations and practical recommendations. *International Journal of Developmental Disabilities, 69*(4), 628–629. https://doi.org/10.1080/20473869.2023.2206686